보건복지부 | 보도참고자료 | 대체불가 대한민국

보도시점 배포 후 즉시 사용 배포 2026. 11. 5.(목)

# 2025년 호스피스 신규 이용 환자 26,020명으로 전년 대비 1,662명 증가

- 2025년 「국가 호스피스·완화의료 연례보고서」, 「연명의료결정제도 연보」 발간 -
- 사전연명의료의향서 약 50만 건 신규 등록, 누적 320만 건 달성 -

**「2025 국가 호스피스·완화의료* 연례보고서」에 따르면 2025년 호스피스 신규 이용 환자는 26,020명으로 전년 대비 1,662명(6.9%) 증가해 2023년 이후 지속 증가하고 있다. 한편, 「2025 연명의료결정제도** 연보」에 따르면** 2025년 **사전연명의료의향서 등록 건수는 499,961건**으로, 2018년 2월 제도 시행 이후 누적 등록 건수는 3,201,958건을 달성했다.

* 말기 환자의 신체적 고통뿐만 아니라 심리적·사회적·영적 어려움을 종합적으로 평가하고 돌보는 전문 의료서비스(2003년~)

** 치료 효과 없이 임종 과정 기간만 연장하는 연명의료를 시행하지 않거나 중단할 수 있는 기준 및 절차를 마련하여 삶을 존엄하게 마무리할 수 있도록 돕는 제도(2018년~)

보건복지부(장관 정은경)와 중앙호스피스센터(센터장 조현정), 국립연명의료관리기관(기관장 백수진)은 **「2025 국가 호스피스·완화의료 연례보고서」와 「2025 연명의료결정제도 연보」**를 통해 **제도 주요 운영 현황과 성과를 공개**했다고 밝혔다.

**<호스피스·완화의료>**

「2025 국가 호스피스·완화의료 연례보고서」는 **호스피스·완화의료 서비스 제공 현황 및 제공기관 개소수, 호스피스 인식도와 만족도** 등을 담고 있다.

**첫째, 2025년 호스피스 신규 이용 환자는 26,020명으로 전년(24,318명) 대비 1,662명(6.9%) 증가**했다. 이는 2023년 22,394명, 2024년 24,318명에 이어 **지속적으로 증가한 수치다.**

둘째, 호스피스 서비스 제공 기반을 살펴보면, 2025년 말 기준 총 194개소로 **입원형 호스피스 104개소, 가정형 호스피스 40개소, 자문형 호스피스 44개소, 요양병원형 호스피스 6개소가** 운영되고 있으며 2024년 말(188개소) 대비 6개소가 증가하였다.

셋째, **대국민 호스피스 인식도 조사에서는 응답자의 83.2%가 호스피스를 들어본 적이 있다고 답해 전년(80.4%) 대비 2.8%p 상승**했다. 또한 응답자의 89.9%가 호스피스가 필요하다고 답했으며, 93.1%는 호스피스 이용 의향이 있다고 응답했다. **특히, 호스피스 전문기관 이용 만족도는 94.7%로 전년(94.3%) 대비 0.4%p 상승하는 등** 인식도와 만족도가 증가하고 있는 것으로 나타났다.

**<연명의료결정제도>**

「2025 연명의료결정제도 연보」는 **사전연명의료의향서와 연명의료계획서 등록** 현황, **연명의료중단등결정 이행** 현황, **환자 및 환자가족 의사 확인** 현황, **제도 수행기관 기관** 운영 현황 등이 수록되었다. 주요 내용은 아래와 같다.

**첫째, 연명의료에 관한 의사를 미리 밝혀두는 국민이 지속적으로 증가하고 있다.** 2025년 **사전연명의료의향서 등록 건수는 499,961건**으로, 2018년 2월 제도 시행 이후 누적 등록 건수는 3,201,958건을 달성했다. 2025년 **연명의료계획서 등록 건수는 29,557건**으로, 누적 등록 건수는 185,952건이다.

**둘째, 연명의료중단등결정 이행 과정에서 환자 본인의 의사를 존중하는 비율도 높아지고 있다.** 2025년 연명의료중단등결정 이행 건수는 81,220건이며, 이 중 **연명의료계획서 또는 사전연명의료의향서를 통해 환자 본인의 의사가 확인된 비율은 52.2%**로 2018년 제도 시행 첫해 대비 19.7%p 증가했다.

**셋째, 국민이 연명의료결정제도를 이용할 수 있는 제도적 기반을 지속적으로 확충하고 있다.** 2025년 **사전연명의료의향서 등록기관은 819개소**(전년 대비 59개소 증가), **의료기관윤리위원회 등록 의료기관은 513개소**(전년 대비 40개소 증가)로 나타났다.

이번 연례보고서는 **국내 호스피스·완화의료 제도와 연명의료결정제도의 현황과 변화 추이를 종합적으로 파악하고, 향후 제도 개선의 기초자료로 활용될 예정이다.** 「2025 호스피스·완화의료 연례보고서」는 **중앙호스피스센터 누리집(hospice.go.kr)**, 「2025 연명의료결정제도 연보」는 **국립연명의료관리기관 누리집(www.lst.go.kr)에서 확인**할 수 있다.

**보건복지부 곽순헌 보건의료정책관**은 "초고령사회 진입과 함께 **생애 말 존엄한 삶의 마무리**에 대한 **국민적 관심이 증가**하고 있다"라며, "앞으로도 국민 누구나 자신의 삶의 마무리에 관한 의사를 충분히 표현하고 존중받을 수 있도록 **연명의료결정제도 및 호스피스·완화의료 제도**가 원활하게 운영될 수 있도록 **지원하고 개선해 나가겠다**"라고 밝혔다.

**<붙임> 1. 2025년 국가 호스피스·완화의료 주요 통계**
**2. 2025년 연명의료결정제도 주요 통계**
**3. 호스피스·완화의료 개요**
**4. 연명의료결정제도 개요**

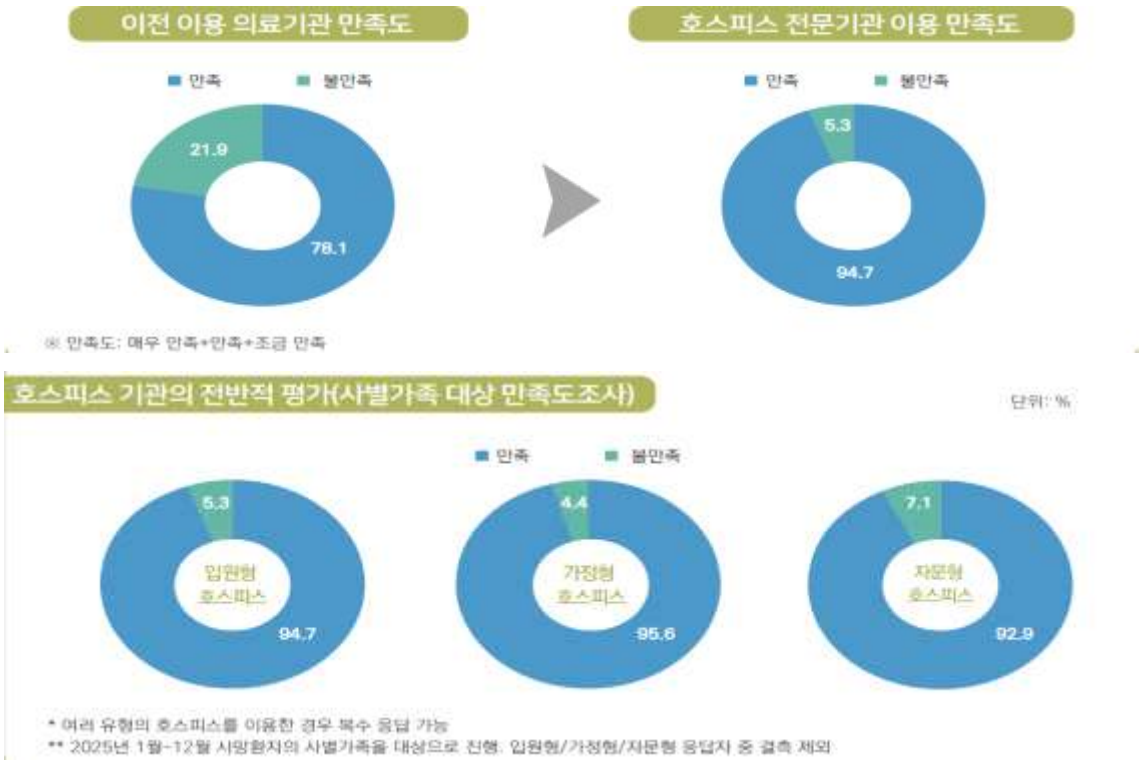
| 담당 부서 | 보건의료정책관<br>생명윤리정책과 | 책임자 | 과 장 | 모두순 | (044-202-2450) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 담당자 | 사무관 | 최지웅 | (044-202-2451) |
| | | | 사무관 | 안현빈 | (044-202-2455) |
| | 국립암센터<br>중앙호스피스센터 | 책임자 | 센터장 | 조현정 | (031-920-2191) |
| | | 담당자 | 질향상교육팀장 | 이현지 | (031-920-1716) |
| | 국가생명윤리정책원<br>연명의료관리본부 | 책임자 | 본부장 | 백수진 | (02-778-7505) |
| | | 담당자 | 팀 장 | 최슬비 | (02-778-7001) |

**붙임 1** **2025년 국가 호스피스·완화의료 주요 통계('25년 말 기준)**

## □ 호스피스 · 완화의료 서비스 기관 및 이용자수




## □ 호스피스 전문기관 이용 만족도



# □ 대국민 호스피스 · 완화의료 인식도

## 1) 호스피스 인지도

단위: 명, %

| 호스피스 인지 여부 | 2024년 | | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|
| | 빈도 | 백분율 | 빈도 | 백분율 |
| 들어본 적 있음 | 1,607 | 80.4 | 1,664 | 83.2 |
| 들어본 적 없음 | 393 | 19.6 | 336 | 16.8 |
| 전체 | 2,000 | 100.0 | 2,000 | 100.0 |

## 2) 호스피스 긍정 인식도

단위: 명, %

| '호스피스' 가 주는 감정 | 2024년 | | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|
| | 빈도 | 백분율 | 빈도 | 백분율 |
| 매우 긍정적임 | 174 | 10.8 | 238 | 14.3 |
| 긍정적인 편임 | 983 | 61.2 | 1,042 | 62.6 |
| 부정적인 편임 | 411 | 25.6 | 371 | 22.3 |
| 매우 부정적임 | 39 | 2.4 | 13 | 0.8 |
| 전체 | 1,607 | 100.0 | 1,664 | 100.0 |

## 3) 호스피스의 필요성

단위: 명, %

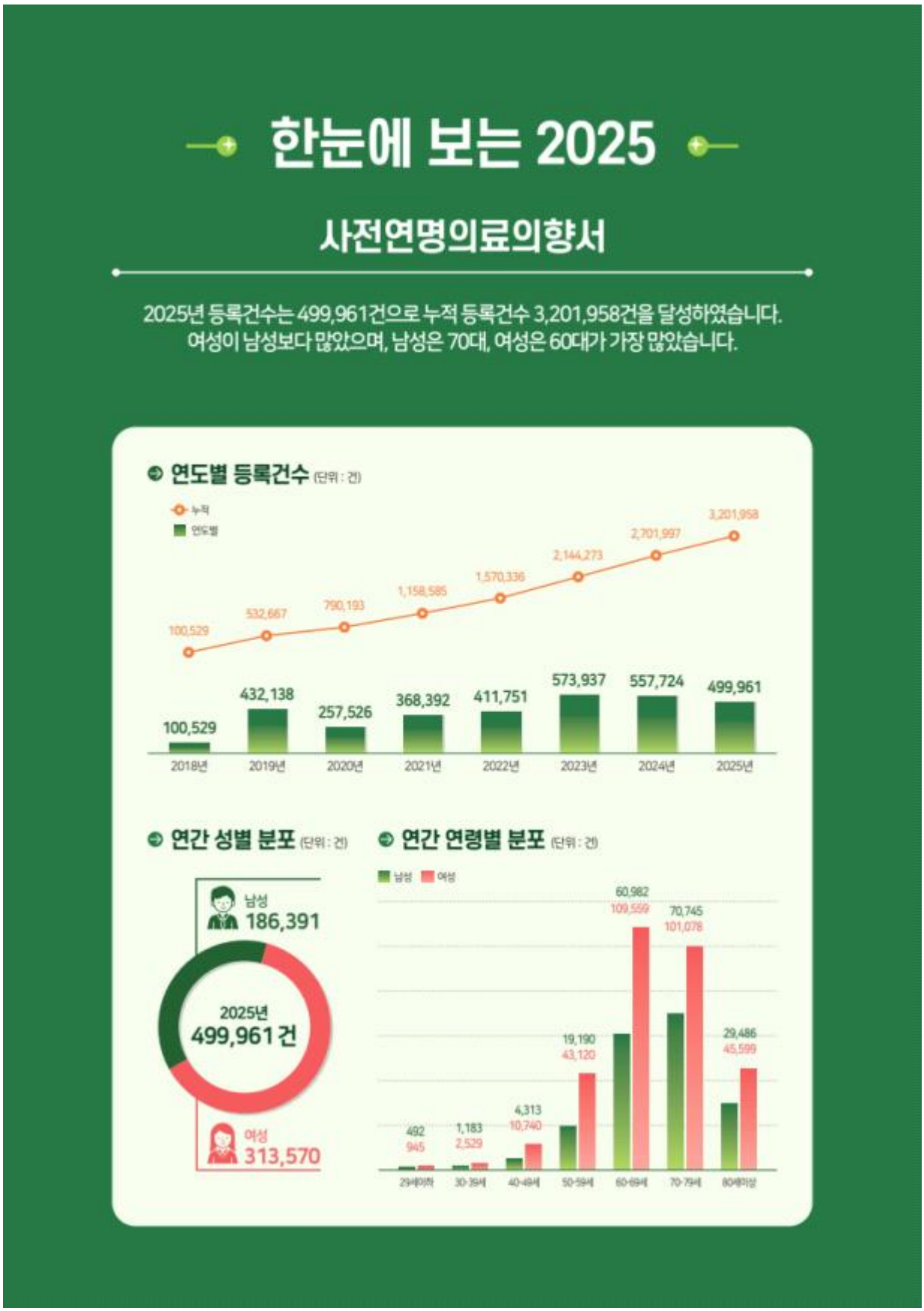
| 호스피스의 필요성 | 2024년 | | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|
| | 빈도 | 백분율 | 빈도 | 백분율 |
| 매우 필요 | 574 | 28.7 | 566 | 28.3 |
| 필요 | 1,236 | 61.8 | 1,232 | 61.6 |
| 불필요 | 174 | 8.7 | 188 | 9.4 |
| 매우 불필요 | 16 | 0.8 | 14 | 0.7 |
| 전체 | 2,000 | 100.0 | 2,000 | 100.0 |

## 4) 호스피스 이용 의향

단위: 명, %

| 호스피스 이용 의향 | 2024년 | | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|
| | 빈도 | 백분율 | 빈도 | 백분율 |
| 이용의향 있음 | 1,842 | 92.1 | 1,862 | 93.1 |
| 이용의향 없음 | 158 | 7.9 | 138 | 6.9 |
| 전체 | 2,000 | 100.0 | 2,000 | 100.0 |

**붙임 2** **2025년 연명의료결정제도 주요 통계('25년 말 기준)**



# 한눈에 보는 2025

## 연명의료계획서

2025년 등록건수는 29,557건으로 누적 등록건수 185,952건을 달성하였습니다.
남성이 여성보다 많았으며, 남성은 60대, 여성은 80세 이상이 가장 많았습니다.

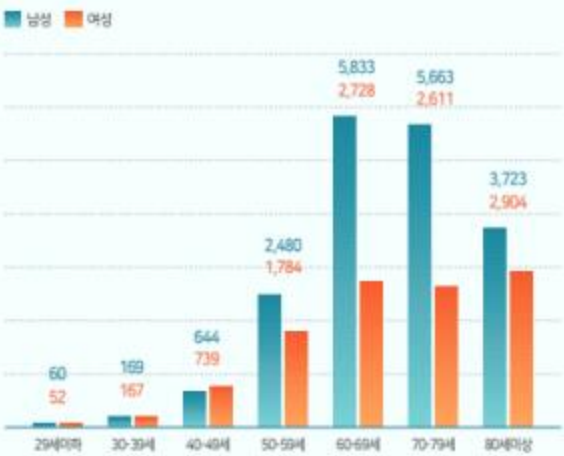
### 연도별 등록건수 (단위 : 건)




### 연간 성별 분포 (단위 : 건)




### 연간 연령별 분포 (단위 : 건)

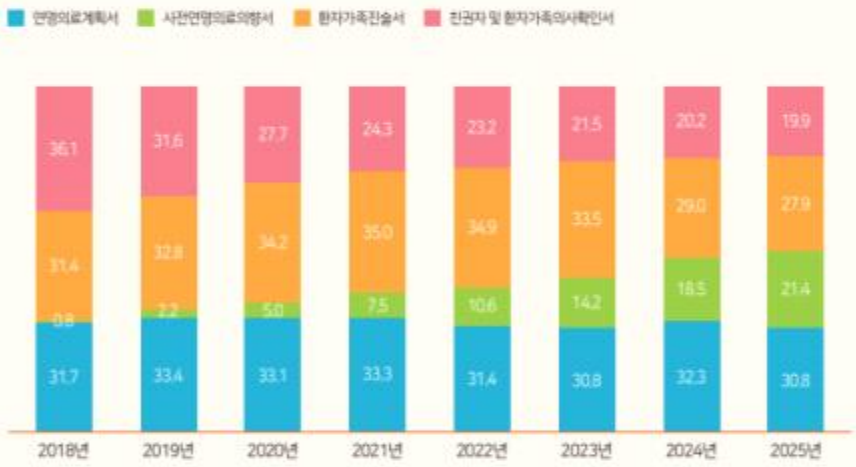


# 한눈에 보는 2025

## 자기결정 존중 현황

환자의사 확인방법 중 친권자 및 환자가족 의사확인서의 비중은 2025년 19.9%로 제도 시행 이래 꾸준히 감소하였습니다. 반면 사전연명의료의향서의 비중은 21.4%로 지속적으로 증가하는 추세입니다.

### 환자의사 확인방법 (단위 : %)




(단위 : 건)

| 구분 | 연명의료계획서 | 사전연명의료 의향서 | 환자가족진술서 | 친권자 및 환자가족 의사 확인서 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 | 10,070 | 250 | 9,981 | 11,464 | 31,765 |
| 2019년 | 16,122 | 1,072 | 15,805 | 15,239 | 80,003 |
| 2020년 | 18,167 | 2,745 | 18,805 | 15,225 | 134,945 |
| 2021년 | 19,133 | 4,291 | 20,136 | 13,951 | 192,456 |
| 2022년 | 20,040 | 6,768 | 22,304 | 14,809 | 256,377 |
| 2023년 | 21,771 | 10,077 | 23,701 | 15,171 | 327,097 |
| 2024년 | 22,663 | 12,936 | 20,298 | 14,164 | 397,158 |
| 2025년 | 25,056 | 17,341 | 22,625 | 16,198 | 478,378 |

**붙임 3** **호스피스 · 완화의료 개요**

## □ 개요

○ **(목적)** 호스피스 대상환자의 존엄한 삶의 마무리를 위해 호스피스 서비스 제공 지원

○ **(대상질환)** 암, 후천성면역결핍증, 만성폐쇄성호흡기질환, 만성간경화, 만성호흡부전

○ **(지원대상)** 중앙호스피스센터(국립암센터), 권역별호스피스센터(11개소*), 호스피스전문기관**, 소아청소년 완화의료 지원사업 수행기관(12개소***)

* 중앙보훈병원, 원자력병원, 인천성모병원, 가천대 길병원, 아주대병원, 충남대병원, 전북대병원, 화순전남대병원, 칠곡경북대병원, 부산대병원, 울산대병원

** 서비스 제공 장소에 따른 호스피스전문기관: 입원형(호스피스 병동) 103개소, 가정형(가정) 40개소, 자문형(일반병동 또는 외래) 45개소
요양병원 호스피스 시범사업 참여기관 5개소(청주원광효도요양병원, 봄날요양병원, 인창요양병원, 전남제일요양병원, 가은병원)

*** 서울대병원, 서울아산병원, 삼성서울병원, 세브란스병원, 서울성모병원, 고대안암병원, 고대구로병원, 국립암센터, 충남대병원, 칠곡경북대병원, 화순전남대병원, 고신대복음병원

## □ 주요 내용

○ 환자 초기 평가 및 돌봄 계획 수립

○ 신체적 돌봄*, 심리적 돌봄, 사회적 돌봄, 영적 돌봄 제공

* 통증 조절, 호흡기계·소화기계 등 증상 조절, 투약 관리 및 주사, 영양 관리 등

○ 임종 관리* 및 사별 관리**

* 임종 준비 교육 및 상담, 임종 증상관리 및 돌봄 등

** 사별가족 위험도 평가, 상실에 따른 정서적 지지와 돌봄 제공

○ 호스피스 제공인력 교육 및 대국민 홍보

## 붙임 4 연명의료결정제도 개요

### □ 연명의료결정제도란?

○ **임종과정**에 있는 환자가 **무의미한 연명의료***를 **시행하지 않거나 중단**할 수 있는 **절차를 마련**하여 **삶을 존엄하게 마무리**할 수 있도록 돕는 제도

* 임종과정에 있는 환자에게 하는 심폐소생술, 혈액 투석, 항암제 투여, 인공호흡기 착용 등 의학적 시술로서, 치료 효과 없이 임종과정의 기간만을 연장하는 것을 의미

### □ 연명의료중단등결정 및 이행 절차

○ 연명의료를 시행하지 않거나 중단하기 위해서는 **❶환자가 임종과정에 있다는 의학적 판단**과 **❷연명의료에 대한 환자 의사 확인**이 필요

- **(임종과정 판단) 담당 의사**와 해당 분야 **전문의 1인**이 판단(총 2인)
- **(의사 확인) 사전연명의료의향서 또는 연명의료계획서**를 확인하거나, 환자가 **의사를 표현할 수 없고** 의향서·계획서도 없는 경우 **가족 확인***

* 환자가 이전에 일관하여 표시한 의사에 대해 가족 2인 이상의 일치하는 진술을 확인하거나, 환자 의사를 전혀 확인할 수 없는 경우 가족 전원 합의 통해 결정

**【 연명의료중단등결정 및 이행 절차 】**




**< 주요 용어 >**

☞ **(사전연명의료의향서)** 19세 이상인 사람이 자신의 연명의료중단등결정 및 호스피스에 관한 의사를 직접 문서로 작성한 것

☞ **(연명의료계획서)** 말기환자 또는 임종과정에 있는 환자의 의사에 따라 담당의사가 환자에 대한 연명의료중단등결정 및 호스피스에 관한 사항을 계획하여 문서로 작성한 것

☞ **(말기환자)** 적극적 치료에도 불구하고 근원적인 회복의 가능성이 없고 점차 증상이 악화되어 수개월 이내에 사망할 것으로 예상되는 진단을 받은 환자(통상 수개월 내)

☞ **(임종과정)** 회생의 가능성이 없고, 치료에도 불구하고 회복되지 않으며, 급속도로 증상이 악화되어 사망이 임박한 상태(통상 수일 내)